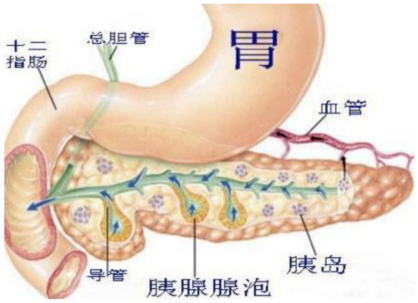
内科学含诊断学 消化系统疾病

核心精讲·急性胰腺炎（内科+外科）

（性感认识：残害自己和祸害他人、SIRS 和 MODS）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图



一、发病机制

①胰酶激活的“扳机”——**胰蛋白酶**→胰腺坏死（凝固性坏死）心肾脾肝胰

急性重型胰腺炎、女性乳房创伤　　可评估胰腺炎的严重程度

②胰脂肪酶→脂肪坏死（特殊液化性坏死）：脂肪酸与钙形成钙皂致**血钙降低**

注意：《生理学》肠腔的脂肪酸与 Ca^{2+}形成钙皂→利于 Ca^{2+}在肠道吸收

促进Ca^{2+}吸收因素:需求量、HCl、VitD、乳酸、葡萄糖、脂肪酸、氨基酸

抑制Ca^{2+}吸收:草酸、磷酸、植酸

③磷脂酶 A→细胞坏死（如溶血）损害细胞膜磷脂双分子层

④弹性蛋白酶→血管坏死（出血、血栓形成）损害血管壁弹力纤维

⑤激肽释放酶→缓激肽↑→血管舒张、通透性增加（水肿、休克）

急性重症胰腺炎（出血坏死型）最常见的并发症是休克

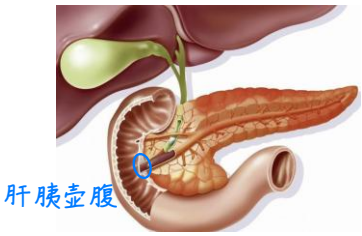
胰腺炎病因:
一、胰酶提前激活:
①排不走:如结石堵住胰管开口→胰管压力↑→胰酶提前激活
②短时间分泌过多胰液:如暴饮暴食→胰液↑↑→胰管压力↑→胰酶提前激活
二、直接损伤:如酒精可以直接损伤腺泡细胞、导管

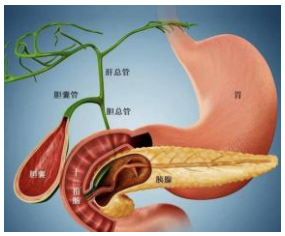
二、病因

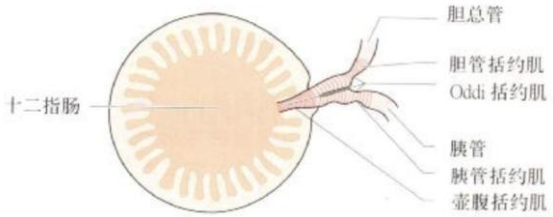
易掉下来

①**胆石症和胆道感染**尤其微小胆石：我国急性胰腺炎最常见的病因（胆源性胰腺炎）

注意：急性胰腺炎严重腹痛时**禁用吗啡**（会增加 Oddi 括约肌压力），可给哌替啶



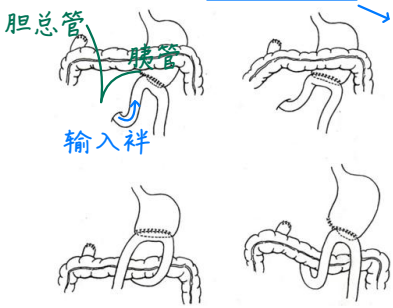




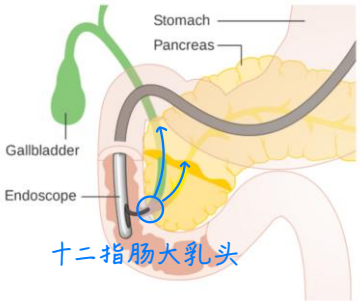
②**酒精**：欧美国家急性胰腺炎最常见的病因 VS 肝硬化最常见原因:乙肝(我国);酒精肝、丙肝(欧美)

③胰管结石、蛔虫、肿瘤等阻塞 胰管堵塞→压力↑→胰酶提前激活

④十二指肠疾病（不常见）：**穿透性溃疡**、十二指肠液反流（十二指肠憩室、胃大部切除术后输入袢梗阻）



十二指肠球部溃疡慢性穿孔、十二指肠球后溃疡:可穿透至胰腺→淀粉酶↑



⑤经内镜逆行胰胆管造影 **ERCP**
- 胰管压力↑→胰酶提前激活→胰腺炎
- 胆管压力↑→胆管炎

注意：ERCP 后若偏左上腹痛→急性胰腺炎；若偏右上腹痛+黄疸→急性胆管炎

胆管炎的Charcot三联征:右上腹胆绞痛、黄疸、寒战高热